

--

Name: هدى عبدالفضيل محمد عبد اللطيف National ID: 28007190104648	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Plus Goserline
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

هـدى
عبدالمصطفى محمد عبدالمطيف صنيان
٢ ش مسجد الاسلام - م. الجبل الاصغر
مركز الخانكة - القليوبية

٢٨٠٠٧١٩٠١٠٤٦٤٨

١٢٣٨٦٩٦٢٧

٢٢٢١/٠١ ٢٨٠٠٧١٩٠١٠٤٦٤٨

ر.ب. منزل

أنثى
مسلمة
محمد ابراهيم نصر ابراهيم

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠١/٢٩

١١

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECISION SUPPORT



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

تاريخ الإصدار: 2022-12-14

جهة الإصدار: فرع القليوبية

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للتأمين الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والبحت تبين أن

السيد (ة) هدى عبدالفضيل محمد بطاقة رقم 28007190104648
وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعة بالتأمين الصحي
وشكرا

تاريخ الطباعة: 2022-12-14

الموظف المختص
محمد سالم

أفادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،

مسلسل 255757



يعتبر هذا الخطاب ساري لمدة شهر من تاريخ الإصدار

الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات ودعم القرار

Name: هدي عبد الفضيل محمد		
MR. : 3976		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحية طيبة وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient is a 42-year-old individual with a history of triple-positive breast cancer (TPBC) diagnosed in 2023 as left-sided breast carcinoma, clinical stage T1N0. Initial management included systemic therapy with KADCYLA, placement of a port for chemotherapy administration, and endocrine therapy with FEMARA and ZOLADEX. The current regimen consists of continued FEMARA combined with supportive care and ZOLADEX administered for a three-month course, with the next follow-up scheduled for 18/11/2026. The patient remains on this endocrine therapy plan.		
تحريراً في ,		
	التاريخ : 19-09-2026	الوقت :
اسماء محمد مصطفى نصر		الطبيب المعالج :
يعتمد ,		



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : هدى عبدالفضيل محمد عبداللطيف Sex:

3- Medical number:
Female

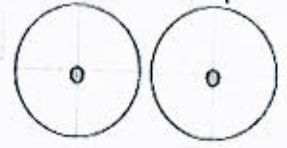
83082548

Old Med :

2403/2022

2-ID number: 28007190104648

Patient Age : 42 Y



Post-NAC
Neo-C

Family history

Phone

01113587741

BMI

REASON OF MDT

POST NACT

marital status

NRS Score

GROUP

Date of MDT

01/18/2023

Co morbidity

HTN

marital status

Menopausal status

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX:

RT IDC GII 5/22

IHC:

ER:

8/8

PR:

7/8

Her 2 Neu :

+3

Ki67 :

T:

2

N

0

M

Sonomammography

Recommendations:

N.B CLIP INSERTED 12/22CT2 N0 --> TCHPX6 CYCLES--> REGRESSION OF RT BREAST
CANCER,,DEVELOPED BLURRED VISION--> OPHTHALMOLOGY CONSULTATION-->
OPTIC PAPILLEDEMA,MRV AND MRI BRAIN WITHOUT CONTRAST 12/22 DONE
N.B PT HAD SYMPTOMS OF IDIOPATHIC UNCONTROLLED HTN

MDT OUTCOME & PLAN

For wire localization of both clipped lesions & SLNB

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	د/ شيماء لاشين	RADIOLOGY	د/ شيماء لاشين
SURGERY	د/ اشرف شوقي	PATHOLOGY	د/ اشرف شوقي
Psychiatric	د/ محمد رشاد شوقي	Nutrition	

18/1/2023

about:blank



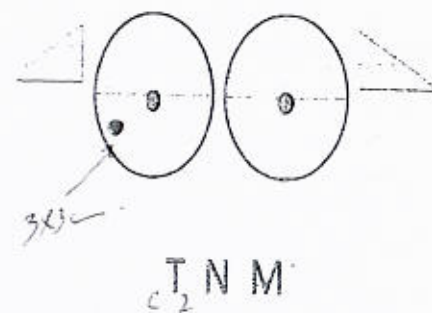
MDT FORM

29/6/2022

Name	د. عبد القادر	MRN	٢٢٠٢/٢٢
Age	٤١	ID	٢٨٠١١/٩١٠٤٦٢٨
Menopausal status		Phone	٠١١٣٥٨٧٧٩١
OCP		marital status	
Co morbidity		Family history	

Clinical Data

Bx:	IDC 9 II			R	L
ER:	8/8	PR:	7/8	HER 2:	amplified
Sonography:	BIRADS 5 Rt = 8 o'clock mass 2x1.5x2 inseparable from the skin.				
Mets Workup:	Bone Scan → Free.				



Recommendations:

- ① Cut results of CBST
- ② Echo
- ③ Labs

No intraductal extension detected by 2nd look US

Re-MDT next week and results of CBST

MDT OUTCOME & PLAN

If proved to be in situ lesion 6/7/2022
for chemo treatment then start ACT
(TCMP X 6) guided by clinical response
then for RT. WLE & SNB.

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY

٢٠٢٢/٧/٦

٢٠٢٢/٧/٦

Patient Name	: الأستاذة / دى عبدالفضيل محمد محمد الدلويف صيام	Request No.	: 13004659
Patient No.	: 28007190104648	Request Date	: 02/07/2022
Path No.	: SR-469/2022	Verification Date	: 16/07/2022
Sex	: Female	Financial Category	: فئة الدولة
Age	: 41 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:

Right breast mass

Nature of the specimen:

Slide revision

Gross Examination:

1 block (4424/22) & 4 slides

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): GII (3+2+1)
- Angiolysis: No
- Ductal carcinoma in situ: No
- Additional pathologic findings: No

Diagnosis:

Right breast mass; Slide revision:

-Invasive duct carcinoma grade-II

-IPT:

-ER: Strong nuclear reaction in more than 70% of tumor cells. Positive, score (8/8)

-PR: Strong nuclear reaction in around 60% of tumor cells. Positive, score (7/8)

-Her-2: Strong incomplete membrane reaction in 10% of tumour cells. Equivocal, score 2+

-SISH: Amplified with clusters (HER2 gene copy number > 6 and HER2/CEP 17 ratio > 2)

Prof. Dr. Lubna Omar

Dr. Abdulrahman Ibrahim

عبد الرحمن إبراهيم

16/7

Verified by :

abdelrahman ibrahim

Printing Date : 16/07/2022 14:44:12

Page 1 of 2

Printing By : abdelrahman ibrahim

Patient Name	: الأستاذة / هدى عبدالفضيل محمد عبد اللطيف صيام	Request No.	: 13000940
Patient No.	: 28007190104648	Request Date	: 09/02/2023
Path No.	: 409/2023	Verification Date	: 19/02/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 42 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:

Right breast cancer , post NACT

Nature of the specimen:

Right WLE & SLNB specimens , collected at 9/2/23

Gross Examination:

3 specimen were recieved :

-SLNB : Fibrofatty tissue peice measured 1.5x1.5 cm , enclosing 4 nodules up to 1 cm

-Extra superior margin : Fibrofatty tissue peice measured 10x7 cm , free of gross induration.

-Right WLE specimen measured 16x9x7 cm with covering skin ellipse measured 13x2 cm

- Tumor extent

o Number: An ill defined firm greyish white tumor bed site (wired and clipped)

o Size: 1x1 cm

- o Skin involvement: Free grossly

- Distance from margins: 0.5 cm from inferior margin (least margin)

- There was a second wired greyish white area (not clipped) measured 1.2 x1 cm

- Frozen section:

- Free SLNs(0/5)

- suspicious superior margin for insitu component

- Free extra superior margin

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma

- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)

-Tumor cellularity:20%

- Angioinvasion: Not detected

- Ductal carcinoma in situ: focal (5%)

Verified by :

dr.esraa magdy

Printing Date : 22/02/2023 13:07:15

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youssef

PATIENT NAME: HUDA ABD EL FADEEL MOHAMMED ABD EL LATIF	PATIENT ID #: 2022192309
GENDER: Female	ORDER #: 1666856,1666857
AGE: 41 y	DATE OF SERVICE: 14-Jun-2022 09:47 AM

Report: - all studies

Multi-slice post contrast CT scan of the chest, abdomen and pelvis revealed:

(I) Chest:

- Small right breast mass seen measuring about 2 x 1.7 cm.
- No parenchymal nodules, cavitary lesions, consolidative patches or bronchiectatic changes.
- No CT evidence of hilar or mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size showing homogenous CT density and enhancement with no focal lesions.
- Patent and homogeneously enhancing portal vein.
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys, aorta and IVC.
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.
- Bulky uterus.
- No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- Left femoral sclerotic focus, likely bone island.

OPINION:

- **Small right breast mass.**
- **No evidence of pulmonary nodules or hepatic focal lesions.**
- **No evidence of sizable metastatic osseous lesions.**

Reported By,

Dr. Ibrahim El Sedawy, MSc
Dr. Mahmoud Saleh, MD

15-Jun-2022 10:37 AM

PATIENT: HUDA ABD EL FADEEL MOHAMMED ABD EL LATIF, 2022192309, Female, 41 y	Page 1 of 1
Report version 2, 25-Jun-2022 12:14 PM	



Patient Name: Hoda Abdel Fadeel Mohamed Abdel Latteef	Date : 07/05/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 43 Year(s)
Medical ID: 2403/2022	Pat. ID: 25699

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH
RESOLUTION ULTRASOUND**

Indication:

Right breast conserving therapy

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)

Right breast:

- Operative bed parenchymal distortion and scarring with no sizable mass
- No suspicious mass lesions, micro calcifications
- No sizable collection
- Diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- No regional lymphadenopathy

Left Breast:

- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- No spiculated mass
- Normal retro-areola ducts
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex
- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post right BCS status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal study of the left breast (BIRADS 1)

Best regards,
Dr. Amira H Radwan MD,
Breast Imaging consultant,
NCI, Cairo University

Patient's Name:

Huda Abdul-Moneim Abdelhalim Eiswa

Date:

2026-09-08

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: Status post right CBS & ALAND, followed by radio therapy, routine follow up study.

Findings:

Right breast.

- Predominantly fatty breast . (ACR a)
- UOQ focal architectural distortion .
- no speculations, masses, asymmetry, or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated UOQ focal area of parenchymal disruption with simple cyst 5mm underneath the operative scar with no solid lesions or fluid collections.
- Normal skin nipple areola complex .
- Clear right axilla. No pathological infra or supra-clavicular lymph nodes

Left breast.

- Predominantly fatty breast . (ACR a)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin, nipple/areola.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion:-

- *Right breast (BIRADS 2): Post-Therapeutic sequelae.*
- *Left breast (BIRADS 1): Normal study*

Recommendation:-

- *For annual follow up.*

Best Regards,

DR. DINA Sayed,Msc

BIRADS classification of breast lesions according to the American College of Radiology used for breast assessment combined with recommendations:

Category & recommendations	Suspected Cancer Risk
BIRADS 0: Non-informative study.	
BIRADS 1: Normal study, routine screening	0 %
BIRADS 2: Benign findings, routine screening	0 %
BIRADS 3: Probably benign, for close follow up.	2 %
BIRADS 4: Probably malignant, for biopsy.	50 %
A: mild suspicion.	
B: moderate suspicion.	
C: high suspicion.	
BIRADS 5: Malignant, for biopsy.	98-100%

BIRADS 6: Pathologically proven malignant

Family History:



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

3- Medical number:

83082548

1- Name : هدى عبدالفضيل محمد عبداللطيف

Sex:

Female

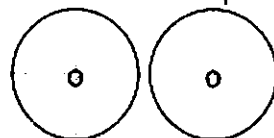
Old Med :

2403/2022

2-ID number: 28007190104648

Patient Age : 42 Y

Post-NACT
New CR



Family history

Phone

01113587741

BMI

REASON OF MDT

POST NACT

marital status

NRS Score

GROUP

Date of MDT

01/18/2023

Co morbidity

HTN

marital status

Menopausal status

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX:
RT IDC GII 5/22

IHC:

ER:
8/8

PR:
7/8

Her 2 Neu :
+3

KI67 :

T:
2

N:
0

M

Sonomammography

Recommendations:

N.B CLIP INSERTED 12/22CT2 N0 --> TCHPX6 CYCLES--> REGRESSION OF RT BREAST
CANCER,,DEVELOPED BLURRED VISION--> OPHTHALMOLOGY CONSULTATION-->
OPTIC PAPILLEDEMA,MRV AND MRI BRAIN WITHOUT CONTRAST 12/22 DONE
N.B PT HAD SYMPTOMS OF IDIOPATHIC UNCONTROLLED HTN

MDT OUTCOME & PLAN

For wire localization of both clipped lesions & SLNB

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	د/ شيماء لاشين	RADIOLOGY	د/ شيماء لاشين
SURGERY	د/ اشرف شوقي	PATHOLOGY	د/ شيماء لاشين
Psychiatric	د/ محمد / اشرف شوقي	Nutrition	

18/1/2023



مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

ت المصرية
 هي
 حقة
 مصر

MDT FORM

/ / 20

G A

Name	هدير عبد الفضيل محمد	MRN	28007190104648
Age	٤٤	ID	٢٨٠٠٧١٩٠١٠٤٦٤٨
Menopausal status		Phone	١١١٢٥٨٧٧٤١
NRS SCORE		Marital status	١٢٤٧٤١٤١٤١
BMI		Family history	
CO morbidity		REASON OF MDT	Post op

Clinical Data

BX:	R	L
ER:	PR:	HER 2:
Ki67:		
Sonomammography:		
Mets Workup:		

Recommendations:

Post Rt WLE + SLNB
 IDC GII Fine margin & extra margin.
 SLNB 0/4 ypT1a ypT0 Omnia Exam
 2422/2023

MDT OUTCOME & PLAN

ypT1b N0/1, H2+, for
 ① TDT2 (total 1/2 anti-her2 or 14 cycles).
 ② Post to Rt. breast ③ ET after hormonal profile
 (A2 +/- 8 weeks)

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الاستشارة
طبية
مصر

MDT FORM

29/6/2022

Name	د. عبد القادر	MRN	٢٢٢/٢٢
Age	٤١	ID	CA-١٧/٩٠١٠٤٦٤٨
Menopausal status		Phone	٠١١١٣٥٨٧٧٤١
OCP		marital status	
Co morbidity		Family history	

Clinical Data

Bx:	IDC 9 II				R	L
ER:	8/8	PR:	7/8	HER 2:	amplified	
Sonomammography:				Rt 8 o'clock mass		
BIRADS 5				inoperable from the skin.		
Mets Workup:				Bone Scan → Free.		
Recommendations:				T ₂ N ₁ M ₀		

- ① Cut results of CEM
- ② Echo
- ③ Labs

No intraductal extension detected by 2nd look US. Pre-MDT met week and results of CEM.

MDT OUTCOME & PLAN

If proved to be in bot lesion 6/7/2022
for chp action to start MACT
(TCMP X 6) guided by clinical response
to be for pt. WLE & LNB.

Accepted
2022/6/29

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY

2022/6/29

2022/6/29



Patient Name : الأستاذة / هدى عبدالفضيل محمد عبد اللطيف صيام	Request No. : 13003940
Patient No. : 28007190104648	Request Date : 09/02/2023
Path No. : 409/2023	Verification Date : 19/02/2023
Sex : Female	Financial Category : نفقة انولة - اورام دار السلام
Age : 42 Y	Department : Our Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:

Right breast cancer , post NACT

Nature of the specimen:

Right WLE & SLNB specimens , collected at 9/2/23

Gross Examination:

3 specimen were recieved :

- SLNB : Fibrofatty tissue peice measured 1.5x1.5 cm , enclosing 4 nodules up to 1 cm
- Extra superior margin : Fibrofatty tissue peice measured 10x7 cm , free of gross induration.
- Right WLE specimen measured 16x9x7 cm with covering skin elipse measured 13x2 cm
- Tumor extent
 - o Number: An ill defined firm greyish white tumor bed site (wired and clipped)
 - o Size: 1x1 cm
 - o Skin involvement: Free grossly
 - Distance from margins: 0.5 cm from inferior margin (least margin)
 - There was a second wired greyish white area (not clipped) measured 1.2 x1 cm
 - Frozen section:
 - Free SLNs(0/5)
 - suspicious superior margin for insitu component
 - Free extra superior margin

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Tumor cellularity: 20%
- Angioinvasion: Not detected
- Ductal carcinoma in situ: focal (5%)

Verified by :

dr.esraa magdy



Patient Name	: الأستاذ / هدى عبدالفضيل محمد عبد اللطيف صيام	Request No.	: 13000940
Patient No.	: 28007190104648	Request Date	: 09/02/2023
Path No.	: 409/2023	Verification Date	: 19/02/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 42 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

- Lymph node involvement: Free SLNs (0/4)
- Resection Margins: Free all resected margins and extra margin
- Histologic response to therapy : Pathologic partial response
- *The second wired area showed only fibroadenosis , free of tumor tissue

Diagnosis:

Right breast cancer post NACT , WLE & SLNB specimens:

- Invasive duct carcinoma , grade II
- Tumor cellularity: 20%
- Free all resected margins and extra margin.
- Free SLNs (0/4)
- Pathologic partial response
- Stage : ypT1a , ypN0
- RCB : 1.561 , class: II

Prof. Gamal Abdelatty

Dr. Esraa Magdy

Verified by :

dr.esraa magdy

ب.ب.ب.

مركز بومة للتحليلات الجزيئية
وعلاج سرطان الثدي

Med. Record No.: 2022192309
Patient Name: HUDAA ABD EL FADEEL MOHAMMED ABD EL LATIF
Sex: Female DOB: 7/19/1980
Nationality: EGYPTIAN
Unit: External Clinic

IMMUNOPATHOLOGY - Final Anatomical Diagnosis

Hormone receptors

Specimen Id 2205300102
Accession No IMM22-3402
Collection Date 5/30/2022 9:50:58AM
Receive Date 5/30/2022 9:51:09AM

Sample Type Paraffin Block
Requesting Doctor Abd ALLAH Mohamed Gamil

Immunohistochemical Report

pathology number

4424/22

Clinical Data

RT breast cancer.

Gross Picture :

Referred block submitted for ER/PR Immunostaining.

System Used :

Ventana BenchMark ULTRA autostainer.

Antibody:

Ventana anti-PR[1E2] Rabbit monoclonal antibody, Ventana anti-ER[SP1] Rabbit monoclonal antibody.

Scoring system :

According to the ASCO/CAP guideline update, 2019 : Samples with 1% to 100% of tumor nuclei positive for ER or progesterone receptor (PgR) are interpreted as positive. If ER (not PgR), 1% to 10% of tumor cell nuclei are immunoreactive, the sample are reported as ER Low Positive. A sample is considered negative for ER or PgR if < 1% or 0% of tumor cell nuclei are immunoreactive. Allred score: proportion of cells staining (0, no staining; 1, <1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%–100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8. Comment: - There are much more limited data on the 2% to 3% of cancers that are low ER expressers (most often defined as 1%-10% ER-positive cells by IHC) and their potential benefit from endocrine therapy. - PR positive in 1-20% of tumor cells is considered as Low positive.

(Laterality) breast Cancer:

Right

Diagnosis :

RT breast cancer:

ER: positive, strong nuclear reaction in 100% of tumor cells (8/8).

PR: positive, strong nuclear reaction in 40 % of tumor cells (7/8).

Signature :

MAHITAB IBRAHIM MOHAMED PHD



٢٠١٢/١٢/٢٠

وزارة الصحة والسكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام
اسم المريض ربابي
رقم الملف الطبي
نوع الوجبة
تاريخ اعداد الوجبة
وقت اعداد الوجبة

وزارة الصحة والسكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز اورام دار السلام

Report
هدى عبد القادر
EC

EF	66%	55-75%	PWT	0.9	0.6-1.1cm
LVEDD	4.2	3.5-5.8cm	AO.R	1.9	2-3.7cm
LVESD	2.6	2-4cm	LA	3.0	2-4cm
FS	38	25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.9	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

✓ systolic function with ✓ internal dimension EF 66%

✓ diastolic function. Grade I

✓ LA dimensions

Normal Ao root dimensions.

✓ Mitral Valve morphology

✓ Aortic valve morphology

✓ Tricuspid valve morphology and leaflets

Normal Pulmonary Valve.

No intracardiac masses or pericardial effusion

Conclusion: 1) 2) grade I

DR. Mohammed A. Wahab



وزارة الصحة والسكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام

وزارة الصحة والسكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز اورام دار السلام

eport

اسم المريض رباعي :
رقم الملف الطبي :
نوع الوجبة :
تاريخ اعداد الوجبة :
وقت اعداد الوجبة :

EF	70	55-75%	PWT	0.9	0.6-1.1cm
LVEDD	4.6	3.5-5.8cm	AO.R	2.5	2-3.7cm
LVESD	2.8	2-4cm	LA	3.0	2-4cm
FS	39	25-45%	RV	/	0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.9	0.6-1.1cm	AO.CUSP	/	1.5-2.6cm

LV dimensions *normal*

LV wall thickness *normal*

LV diastolic function *normal*

SWMA *normal*

LA and Aortic root dimensions *normal*

Mitral Valve *normal*

Aortic valve *normal*

Tricuspid valve

Pulmonary valve

Right side and systolic function

Intracardiac masses and effusion

D/ Msc cardiology

٢٤.٢
٢٢

٢٤/٥/٢٠٢٣

Echo report

Name:

Date: 24/5/2023

EF	67	55-75%	PWT	1.0	
LVEDD	50	3.5-5.8cm	AO.R	2.5	2-3.7cm
LVESD	3.1	2-4cm	LA	3.3	2-4cm
FS	37	25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	1.0	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions Normal

LV wall thickness Normal

LV diastolic function Grade II dd

SWMA No

LA and Aortic root dimensions Normal

Mitral Valve Normal

Aortic valve Normal

Tricuspid valve Normal

Pulmonary valve Normal

Right side and systolic function Normal

Intracardiac masses and effusion No

D/ Msc cardiology

د/نا رسلان



وزارة الصحة والسكان
امانة المستشفى الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام

م/ محمد عبد الفيل
Echo report

Name:

Date: 7/9/2023

MR ٢٤٢ / ٢٢

EF	64%	55-75%	PWT	0.9	0.6-1.1cm
LVEDD	4.05	3.5-5.8cm	AC.R	3.2	2-3.7cm
LVESD	2.7	2-4cm	LA	3.2	2-4cm
FS	34%	25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.9	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions

LV wall thickness

LV diastolic function

SWMA NO RWMA at rest

LA and Aortic root dimensions

Mitral Valve

Aortic valve

Tricuspid valve

Pulmonary valve

Right side and systolic function

Intracardiac masses and effusion NO

D/ Mohamed Ali

Msc cardiology

PATIENT NAME: HUDA ABD EL FADEEL MOHAMMED ABD EL LATIF GENDER: Female AGE: 41 y	PATIENT ID #: 2022192309 ORDER #: 1666855 DATE OF SERVICE: 14-Jun-2022 11:15 AM
--	---

Report:

99mTc-MDP BONE SCAN

Desired Information :- skeletal survey.

Technique:

Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 minutes & 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99mTc-MDP:

FINDINGS:-

No definite hot or cold spots that would account for serious bone lesions.

Arthritic changes at shoulders.

Degenerative changes at the spine, more advanced at upper lumbar for follow up.

Both kidneys are seen.

CONCLUSION:-

No definite evidence of metastatic osseous deposits.

Reported By,

Ass. Prof. Huda Fathy Elsayed

18-Jun-2022 03:30 PM

MRI BRAIN WITH CONTRAST:

- Normal size shape & position of the cerebral ventricles with no midline shift or deformity.
- Normal gray-white matter interface with no areas of abnormal signal intensity.
- No evidences of mass lesions.
- No gross vascular abnormality.
- Normal cerebellum, brain stem & cervico-medullary junction.
- Normal sellar region.
- Normal extra-axial spaces.
- Prominent cisterna magna

Prof. Dr. Sheriff Abdel-Fatah

Hala

Dr. Karim



Patient Name: houda abdel fadeel mahmoud

Date: 07.02.2023

Mammographic Guided Stereotactic Wire localization:

Clinical summary: RT breast CA that was under NAC. For localization of two RT breast clips at 10:00, & 9:00.

Technique:

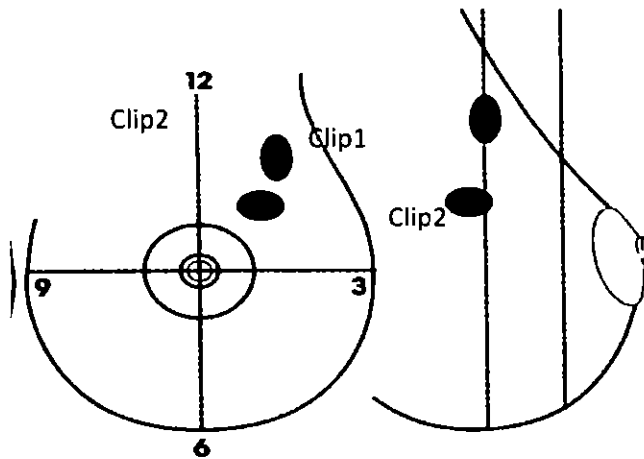
Under complete sterile conditions, 3ml of local anesthetic were administered at the site of concern in the RT breast. A 21G wire was used to localize the two clips

Clip 1: located at 10:00, 5 mm deep to the skin, and 6cm from the nipple.

- The wire was inserted about 1.4cm from the skin mark over the clip, the hook is over the clip.

Clip 2: located at 9:00, 5 mm deep to the skin, and 6.4cm from the nipple.

- The wire was inserted about 1.2cm from the skin mark over the clip, the hook is over the clip.



Best Regards
Dr hanaa abou el magd

PATIENT NAME: HUDA ABD EL FADEEL MOHAMMED ABD EL LATIF	FATIENT ID #: 2022192309
GENDER: Female	ORDER #: 1634968,1634969
AGE: 41 y	DATE OF SERVICE: 28-May-2022 01:11 PM

Report: - all studies

**DIGITAL MAMMOGRAPHY OF BOTH BREASTS & COMPLEMENTARY
ULTRASOUND**

- ACR C; Heterogenous fibroglandular breast parenchyma

Right breast :

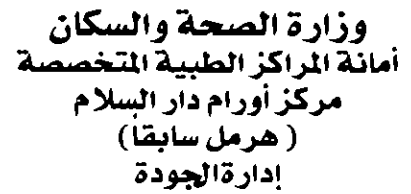
- High dense irregular mass lesion, of obscured margin seen at right breast upper outer quadrant.
- Complementary US shows heterogeneously hypoechoic irregular mass . It is seen at the 8 O'clock at 8.7 cm from nipple , showing surrounding echogenic halo & measuring about 2x1.5x2 cm in maximum diameters. It is seen inseparable from overlying skin, showing anterior extension for 2 cm (? ductal extension). High vascularity noted within the lesion.
- Normal contour and skin thickness.
- Normal nipple- areola complexes.
- Few prominent axillary lymph nodes , with preserved fatty hila and average cortical thickness. likely non specific
- Free supra- and infra- clavicular regions

Left breast:

- No speculated mass lesions or microcalcific clusters.
- No solid or mass lesions.
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complexes.
- Nonspecific axillary lymphadenopathy.

CONCLUSION:

- Right 8o'clock suspicious looking mass lesion as described above for histopathological confirmation (BIRADS 5)
- Left breast fibrocystic mammary changes (BIRADS 2).



التاريخ: / /
الوقت:

إيمان سيف الدين

Prof. & Chairman, Dept. of Neurology

عضو الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب

المصلحة لنا في هذا الأمر
للقسم الأول ودراسة
وتم عمل يزل للبناء على
وغيره في كنفه - وتم أخذ
للفتح وتم أخذ طيات
115
80
للمرارة الملحة

بجوار صيدلية أميرد ت: ٧٦ . ٩١٣٤٦ . ١ .

42 J BMI 27.5
67 kg Adj 56 kg

156 cm

S.A 1.7



EF647 31/7/2022

CITCHP

TAXOTERE

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
هرمل، سابقاً

7661

7

0000 1 7 100

اليوم والتاريخ: الخميس

الرقم الطبي:

اسم المريض: هدى عبد الفضيل

Drug	Time	Signature
zofran 8 mg + Dexamethasone 8 mg + zantac 8 mg + avil 2ml .in 100 ml G5/S sol. over 10 min أمبول زنتاك + أمبول أفيل + أمبول ديكالرون + أمبول زوفران في ١٠٠ مل محلول ج/ملح على مدى ١٠ دقيقة → 130mg		
Docetaxel (75mg/m ²) / 50mg in 500ml G5% over 1 hr تاكسوتير _____ مجم في ٥٠٠ مل محلول جلوكوز ٥% على مدى ساعة		
G5/S sol. 100 ml over 15 min. ١٠٠ مل محلول ج/ملح على مدى ١٥ دقيقة		

herceptin 600 mg S.C
perjeta 840

• Chemotherapy treatment: N.B. Dose modification: _____ %

Carbo AUC (5)

R/ Decadron 8mg amp/ methabiogen 8mg tablet	حقنة بالعضل/أو قرص كل ١٢ ساعة لمدة يومين بعد الجرعة و واحد قبل الجرعة القادمة
R/ Motilium tab.	قرص قبل الأكل بربع ساعة ٣ مرات يومياً لمدة أسبوع
R/ Zantac 300mg or controloc 40mg	قرص قبل العشاء يومياً لمدة أسبوع
- Controloc 40 mg	
- Celebrex 200mg	قرص ١/٢ ساعة أسبوع
- Felaged 500mg	قرص ١/٢ ساعة أسبوع

Major Drug Interactions

Docetaxel: caution with erythromycin,
ketoconazole (Nizoral), clozapine
(antipsychotic), phenytoin (Epanutin),
digoxin (Lanoxin).

CITCHP
A. Ph Aya

Doctor's Name:
2219

تاريخ التاريخ (الرجاء)

دا هدى
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

طبيبية خارجية

Pharmacist's Name:

New Echo Net
G. Ph
0000000000



وزارة الصحة والداخلية
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

أوامر الطبيب Doctor's Orders

اسم المريض :
الرقم الطبي :

الأوامر

chest:.....

Temp:.....

Oral mucositis:.....

Canula site infection.....

مينا ميرجيس

أ.د. أحمد
أ.د. أحمد

توقيع الطبيب :

/ / التاريخ:
الوقت:

الأوامر

chest:.....

Temp:.....

Oral mucositis:.....

Canula site infection.....

توقيع الطبيب :

/ / التاريخ:
الوقت:



Age 42
wt 56
HT 156
S.A 1,56
~~ABW 56~~

SR.CT (0.8) → C₂ TC 1/4

Carbo (530 mg) → C₃ TC 1/4

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

Age: 42

ABW: 56

SR: 1.1

chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

C₂ TCHP

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

premaupl Rr Brtr c

CT₂ , N₀ , H₀
IDCII

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقا)
إدارة الجودة

Erta 3/8, PN to 7/8, 14er 2g

Doctor's Orders أوامر الطبيب

..... اسم المريض :

..... الرقم الطبى :

الأوامر

chest:.....

Temp:.....

Oral mucositis:.....

Canula site infection.....

me for the best of you and your family

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

convex

For pyridine

توقيع الطبيب :

الوقت: ٥٠ دقيقة



chest: Ca 12/10

Temp:.....
Oral mucositis:.....

Oral mucositis.....
Canula site infection.....

Epiphyse

Q. Growth formula.

$\frac{1}{2} \times 10 \times 1$

By Calculation

12

توقيع الطبيب: د. الكويعي

التاريخ: ١٤ / ١ / ٢٠٢٣

الوقت:

wt: 72
ht: 156
SA 676
ABW 58
ST. OR (8.9) → 11/10
Carb. (498 mg) → C5 (15/11)

Age 42
wt 72
Ht 156
SA 676
ABW 58
ST. OR (8.9) → 11/10
Carb. (498 mg) → C5 (15/11)

Echo (15/11/2022) → 70%

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض: هادي عبد الوكيل محمد
الرقم الطبي: ٥٠٣ / ٥٠٤

الأوامر

chest:
Temp: 38.2 - 11.2.22
Oral mucositis:
Canula site infection: grade 1 PN

R eye afferent
منه

grade 2 OT

O/E: PR O O O
No ax. LN.

ph/Ap Fage 2
C5 TC (498 mg)
C5 phage
15/11/2022

Lab T/C 4.9/3.1

EF 70% on 15/11

Hb 9.7, PLT 171

MCV: التاريخ 73, MCH: 22

توقيع الطبيب:

ALT 30.9, AST 30, S-Cr 0.9, UAc 5, BUN 6

C5 TCHP الأوامر

chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canula site infection:

120
AUC 5
phage

توقيع الطبيب:
تاريخ:
الوقت:

مستشفى دار السلام
إدارة الجودة

د. عبد الله
15/11

15/11/2022
15/11/2022



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

PT HTN.

عبد الله بن عبد الله

Doctor's Orders أوامر الطبيب

Co 8 Bls 3 fluids.....

ophthalic canula → merkel papillitis

MRC brain → per optic csh signal

chest:.....

Temp:..... mild Bil + morily + ellad sides

Oral mucositis:..... + pom → megacystes mag 4

Canula site infection:..... C6 TCHP.

120 حر 120 حر 120 حر

2600 480 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

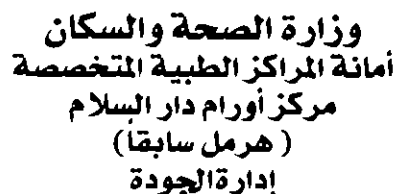
100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100



No cord of thrombus



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :
الرقم الطبي :

الأوامر

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection:.....

L. Lab, TLC 8.2, Hb 7.9, plt 122

ALT 28.3, AST 15.4, Cr 1.5, Na 138

K 3.5, Ca 7.6, VAn 4, T-bil 0.4

توقيع الطبيب :
VBG plt: 7.39
التاريخ : / /
الوقت : ع

EF 66% 4/11/2022

الأوامر HDT:.....

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection:.....

Temp: 38.2, RUC 2.2

CHP

توقيع الطبيب :
VBG plt: 7.39

التاريخ : / /
الوقت : ع

توقيع الطبيب :
VBG plt: 7.39

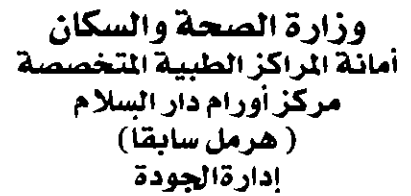
CHP

4/11/2022

د. ربيع
4/11/2022

د. ربيع
4/11/2022

د. ربيع
4/11/2022





وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :
الرقم الطبي :

الأوامر	70kg
chest:.....	
Temp:.....	
Oral mucositis:.....	
Canula site infection:.....	
969 m 7 DM /	
(Jantam 25)	
C. Kad	
cl-ph Aya	
22/3	
التاريخ:	الوقت:

الأوامر	C ₂
chest:.....	
Temp:.....	
Oral mucositis:.....	
Canula site infection:.....	
C ₂	
C. Kad	
cl-ph Aya	
22/3	
التاريخ:	الوقت:



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

4/1/2023

Doctor's Orders أوامر الطبيب

EF 667,

اسم المريض :
الرقم الطبي :

الأوامر

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection.....

Clo. epistaxis following
Kadcyla 8.4 BP

Hb=9.8, Plt=220, Tlc=5.7

(C3) Kadcyla 260 mg

2 gm / Ora / Av. / Concom. قبل العلاج

Penicillin 3 x 1 x 1

Osteocin 3 x 1 x 1

Paracetamol 1 x 1 x 1

Diclonal 1 x 1 x 1

Kosaklon 1 x 1 x 1

Stimulant 1 x 1 x 1

توقيع الطبيب : د. محمد بن عبد الله

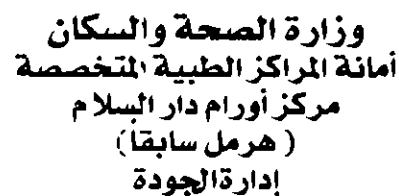
التاريخ: 4/1/2023
الوقت:

الأوامر

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection.....

توقيع الطبيب :

التاريخ: / /
الوقت:



Echo (24/5/2023) 67 %.

$w_t = 70 \text{ kg}$

Doctor's Orders أوامر الطبيب

8. Cont 1. S
AIT 49
AIT 51

اسم المريض : EF 67%
الرقم الطبي : (هدى) عيسى (الفصل) محمد ٩٢٣ / ٩٤٤

chest:..... Potent ^{2019/8/1} fntct today
Temp:.....
Oral mucositis:..... B Cdx 4 100dch/3
Canula site infection:.....

→ Start in post history of bilateral

BP. Medans Grad IV

4 Glycol sp

4. Doktorin ord. gel

✓ Femora 1X1X30

11 Calc 1x 1x 30

My legation 1407 1X3X3A.

التاريخ: ١٩٢٢
الوقت: ١٩٢٢

1) Controlloc 4m to 1x 1x 30

chest:..... *W. Motel* *fb* *1x3x16*

Temp:.....
Oral mucositis:..... *1/2 ulcer 10-8*

Canula site infection.....

On 4/6

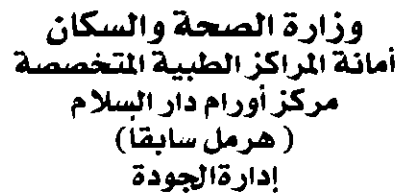
ph / Aya fanez.

Cy Kadca

260 mg

24/5/2023

التاريخ: / /
الوقت:



التاريخ: / /
الوقت:



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :
الرقم الطبي :

الأوامر

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection:.....

C7 Kadyla

27/7/2023

27/7/2023

27/7/2023

27/7/2023

27/7/2023

27/7/2023

27/7/2023

27/7/2023

27/7/2023

27/7/2023

27/7/2023

27/7/2023

27/7/2023

27/7/2023

27/7/2023

27/7/2023

27/7/2023

27/7/2023

27/7/2023

27/7/2023

27/7/2023

توقيع الطبيب :

C. P. 17/17

الأوامر

C7 Kadyla (252mg)

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection:.....

*Labr: OK

*she started PORT

*Tab: (C8) Kadyla 260mg Today: 27/7/2023

*Tab: Temara 2.5mg Tab. 1x1x30 days

*Tab: calcium Tab. 1x1x30 days

.....

.....

.....

.....

.....

.....

توقيع الطبيب :

التاريخ: 27/7/2023
الوقت:

C. P. 17/17
2023



Dr 641 7/19/2023

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Dr R
Cycle 9 TDM

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض: Dr. R
الرقم الطبي: 641
الأوامر

chest:.....

Temp:.....

Oral mucositis:.....

Canula site infection:.....

250 mg TDM

fermar 4 & 30

one 10h OS

climdt 10

التاريخ:

الوقت:

توقيع الطبيب

noth cram

الأوامر

chest:.....

Temp:.....

Oral mucositis:.....

Canula site infection:.....

2000 mg

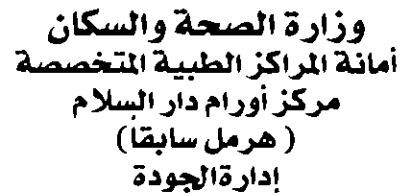
panadol 2x3

التاريخ:

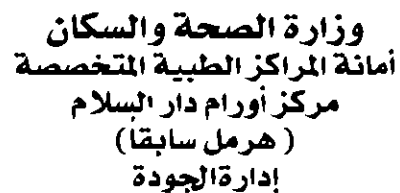
الوقت:

توقيع الطبيب

617



الموقت:



اسم المريض : محمد بن الفضل محمد
الرقم الطبي : ٢٤٣ / ٢٠١٩

hold one week

الوقت:

سیریس کے کہ
الانوار

ila site infection.....

Post Pended

This week on pt 1 92

15. Advise on Data Math

①

18 119

2023.

التاريخ:

الوقت:



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض:
الرقم الطبي: ٢٢٠٢٠٢٢

الأوامر

chest:.....

Temp:.....

Oral mucositis:.....

Canula site infection:.....

AST 42

AST 50

AST 86

٢٥/١٢/٢٠٢٢

٢٥/١٢/٢٠٢٢

توقيع الطبيب: ٢٥/١٢/٢٠٢٢

٢٥/١٢/٢٠٢٢

التاريخ: ٢٥/١٢/٢٠٢٢
الوقت: ١٢/١٢/٢٠٢٢

الأوامر

chest:.....

Temp:.....

Oral mucositis:.....

Canula site infection:.....

AST 82

C12

C12 Ka Jr

٢٥/١٢/٢٠٢٢

٢٥/١٢/٢٠٢٢

٢٥/١٢/٢٠٢٢

التاريخ: ٢٥/١٢/٢٠٢٢
الوقت: ١٢/١٢/٢٠٢٢

٢٥/١٢/٢٠٢٢

٢٥/١٢/٢٠٢٢
١١/١

٢٥/١٢/٢٠٢٢



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض: هـ. ت. ع. م. / الف. م. م.
الرقم الطبي: ٢٠٢٠ / ٢٠٢٠
Zometa / 6mr

الأوامر

chest:.....

Temp:.....

Oral mucositis:.....

Canula site infection:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

+ Dent
Ass
Dear Colleague,
This patient needs
to be followed here
Zometa III due to
indication of
Extraction of
multiple teeth
Thank you,
Dr. Khaled Elsayid
8/1/25

توقيع الطبيب:

التاريخ:
الوقت:
.....

الأوامر

chest:.....

Temp:.....

Oral mucositis:.....

Canula site infection:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

توقيع الطبيب:

التاريخ:
الوقت:
.....

الأوامر

chest:.....

Temp:.....

Oral mucositis:.....

Canula site infection:.....

.....

.....

.....



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض : د. عبد الحليم
الرقم الطبي : ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢

الأوامر

chest: 21/4/2025

Temp:

Oral mucositis: R/ Zolader 10.3 - 1

Canula site infection:

R/ Feme 2.5 - 1x

R/ Rose Alfa tabs

R/ Calcite tabs

R/ Paracetamol 1x2

R/ Gupl 300 tabs

R/ Fuside C 1x3

R/ Zomet (لم يصف)

التاريخ:
الوقت:

for SM + lab

3 months

توقيع الطبيب :

٢٤/٤/٢٥
٧/١٥

الأوامر

chest:

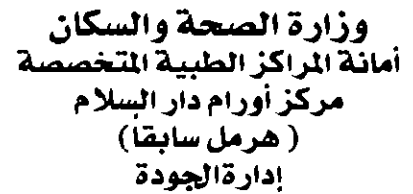
Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

توقيع الطبيب :

التاريخ:
الوقت:



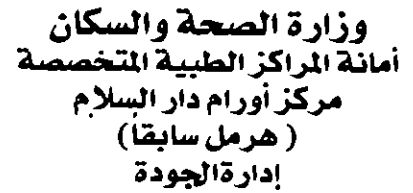
اسم المريض :

الرقم الطبي :

سما مکت

CIV

فردوس



اسم المريض : هادي محمد المصيل
الرقم الطبي : ٢٠١٤٠٢

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection.....

توقيع الطبيب :
 تاريخ:
 الوقت:

la site infection

مرحباً بالجميع (سلام)

C13 Kadanya Chipl

22/11/2023

توقيع الطبيب :

التاريخ:

عالم الوقائع

477101/200

5/11/17

مفت یاسی ۵۲۸۱

جیٹا / جیٹا / جیٹا
2021/11/11



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض:
الرقم الطبي:

الأوامر

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection:.....

De Quervain disease

R. Amoxicillin 2000 mg po bid
R. Sulfur gel bid
R. Amoxicillin 2000 mg po bid
R. Metronidazole 500 mg po bid

توقيع الطبيب:
التاريخ: ٢٤/٤/٢٠١٤
الوقت: ١٢:٠٠

الأوامر

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection:.....

De Quervain disease

R. Amoxicillin 2000 mg po bid
R. Sulfur gel bid
R. Paracetamol 500 mg po bid
R. Metronidazole 500 mg po bid

التاريخ: ٢٤/٥/١٤
الوقت:

توقيع الطبيب:



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :
الرقم الطبي :
تاريخ : ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٢٣

الأوامر

chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canula site infection:

تاريخ: ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٢٣
الوقت:
توقيع الطبيب:
أوامر الطبيب:
١- متابعة المريض
٢- متابعة المريض
٣- متابعة المريض
٤- متابعة المريض
٥- متابعة المريض
٦- متابعة المريض
٧- متابعة المريض
٨- متابعة المريض
٩- متابعة المريض
١٠- متابعة المريض

الأوامر

chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canula site infection:

تاريخ: ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٢٣
الوقت:
توقيع الطبيب:
أوامر الطبيب:
١- متابعة المريض
٢- متابعة المريض
٣- متابعة المريض
٤- متابعة المريض
٥- متابعة المريض
٦- متابعة المريض
٧- متابعة المريض
٨- متابعة المريض
٩- متابعة المريض
١٠- متابعة المريض



PERSONAL HISTORY التاريخ المرضي

Patient name: هدى عبدالقادر Mr.no: Premenopausal
Age: 41 Sex: ☐ Male ☒ Female • OCP
Occupation: House • SCs
Marital History: ☒ M ☐ S ☐ W ☐ D • Irregular Menses.
Children: ☒ Yes ☐ No number 3 youngest 5 yrs
Special Habits: ☒ Smoking ☐ Coffee ☐ Alcohol
Allergy : ☐ Yes ☐ No Comment: Sinusitis
Adverse drug reaction: ☐ Yes ☐ No Comment: Allergy Form Contrast
Complaints:
Present History:
It breast ca IDCII Mass of 4M
CT. No Mo. CTs
Bone Sc.
for TCHP

Past History (hospital admission & surgery):

• surgical: 5 CS

• Diabetes mellitus: ve

• Blood Transfusion: ve

Family History:

Psychosocial History: ve

Checked & Reviewed by Dr.

Date: Time:

 أسامير الطبيب / الفحوصات المطلوبة Physician's Orders / Investigation	اسم المريض / :		
	الرقم الطبي :		
	تاريخ الدخول :	الجنس :	العمر :
	القسم :	الدور :	رقم أذن القبول :
	المعاملة المالية :		

نوع التغذية :

حسب جلد المريض

التشخيص :

التاريخ	الوقت	أوامر الطبيب / الفحوصات المطلوبة	توقيع الطبيب
		(إلى مستشفى علاج الحروق) May I refer back to you this patient ♀ patient, case of RT BC - Received WART then RT WLE + axillary clearance - ypt, ypm Received PORT RT WBE + Boost 40 Gray/15 fractions Ended on 29/8/2023 for your care أ. حارث محمد عيسى عائشة م. نورة ع. ع. ع. ع. ع. ع. ع. ع.	

ملحوظة : جميع الأوامر الطبية لا يتم أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب .



Document Control